Centro Endoscopico Digestivo Aurelia Nova
Servizio di Endoscopia Digestiva e Sedazione
Struttura privata accreditata - Direttore Sanitario Dott. M. Cardelli

Circonvallazione dei Gelsi 212
00165 Roma
Tel. 06 3928 4410
endoscopia@aurelianova.example.it

REFERTO DI COLONSCOPIA

Pancolonscopia con polipectomia in sedazione profonda

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**Vincenzo Sabatini**
Nato il:	**02/12/1947 (aa. 76)**
C.F.:	**SBTVCN47T02H501R**
Tessera SSN:	**80380050316635675729**

N. esame: END-2406-03391

Data esame: 26/06/2024
Inviante: Dott. Enzo Proietti (MMG)

Persone presenti / di riferimento

Ruolo	Nominativo	Recapito
Caregiver (figlia)	Patrizia Sabatini	+39 328 661 0473
Endoscopista	Dott. Fabrizio Melis	interno 214
Anestesista	Dott.ssa Carla Iannone	interno 230
Infermiera di sala	Rita Ferrante	-

INDICAZIONE E ANAMNESI

Indicazione: sangue occulto fecale positivo allo screening e anemia microcitica lieve. Il pz. è affetto da fibrillazione atriale permanente in terapia con apixaban 5 mg x 2, sospeso 48 ore prima dell'esame su indicazione del curante, e da BPCO di grado moderato. Il consenso informato è stato firmato dal paziente alla presenza della figlia, sig.ra Sabatini Patrizia, che lo accompagna e lo riaccompagnerà a domicilio.

PREPARAZIONE E SEDAZIONE

Preparazione con PEG 2 L in dose frazionata. Pulizia intestinale secondo Boston Bowel Preparation Scale: BBPS 7 (2-3-2). Sedazione profonda con propofol 140 mg in boli frazionati, in respiro spontaneo con O2 in occhialini, monitoraggio di SpO2, ECG e PA. Nessun evento avverso.

DESCRIZIONE

Esplorazione fino al cieco, identificato dalla valvola ileo-ciecale e dall'orifizio appendicolare; intubazione dell'ileo terminale per circa 5 cm, di aspetto normale. Tempo di retrazione 9 minuti. Numerosi diverticoli del sigma e del discendente, senza segni di flogosi. Riscontro delle lesioni riportate in tabella, asportate e recuperate per esame istologico.

N.	Sede	Morfologia (Parigi)	Dimensione	Tecnica	Contenitore
1	colon ascendente	0-Is	12 mm	polipectomia con ansa a freddo	AN24-03391-A
2	colon trasverso	0-IIa	6 mm	ansa a freddo	AN24-03391-B
3	sigma	0-Ip	18 mm	ansa diatermica, clip emostatica	AN24-03391-C

CONCLUSIONI

Polipi multipli del colon (n. 3) asportati endoscopicamente in modo completo. Malattia diverticolare del colon sinistro non complicata. Campioni inviati al Laboratorio Istopatologico Tevere; l'esito sarà disponibile in circa 15 giorni lavorativi e verrà consegnato al sig. Sabatini o a persona delegata.

Indicazioni post-procedura

Dieta leggera per 24 ore. Riprendere apixaban dalla sera del 28.06.24 in assenza di sanguinamento. Non guidare né firmare atti legali per le 12 ore successive alla sedazione. In caso di rettorragia, dolore addominale intenso o febbre contattare il centro o recarsi al Pronto Soccorso. La colonscopia di sorveglianza andrà programmata in base all'esito istologico, indicativamente entro 3 anni.

Il Medico Endoscopista

Dott. Fabrizio Melis
Specialista in Gastroenterologia

ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Dott. Fabrizio Melis
OMCeO Roma n. M-48117

Roma, 26 giugno 2024

L'Anestesista

Valutazione anestesiologica: ASA III

Dott.ssa Carla Iannone